Estilo UERJ

Simulado 11 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 26 anos, que faz sexo com homens, foi tratado há 3 semanas por uretrite com secreção mucopurulenta, com ceftriaxona 500 mg IM e azitromicina 1 g VO em dose única. Tomou corretamente, o parceiro fixo foi tratado com o mesmo esquema e nega nova exposição. Persiste com disúria e secreção uretral escassa e clara desde então. Bacterioscopia da secreção: mais de 5 polimorfonucleares por campo, sem diplococos gram-negativos. Os testes moleculares para gonococo e clamídia, colhidos agora, são negativos, assim como o teste molecular para Trichomonas vaginalis. Sem úlceras, sem lesões perianais; sorologias para sífilis e HIV não reagentes. O agente mais provável da persistência é:

A) Neisseria gonorrhoeae resistente

B) Chlamydia trachomatis

C) Mycoplasma genitalium

D) Herpes simples tipo 2

---

2 Homem de 71 anos, assintomático, traz hemograma de rotina: Hb 13,6 g/dL, leucócitos 21.400/mm³, linfócitos 17.600/mm³, neutrófilos 3.300/mm³, plaquetas 182.000/mm³. O clínico atribuiu a linfocitose a um quadro gripal de 1 mês atrás. Hemograma de 5 meses atrás, feito para cirurgia de catarata, mostrava leucócitos 16.900/mm³ e linfócitos 12.800/mm³. Nega febre, sudorese noturna ou perda de peso. Exame físico sem linfonodomegalias palpáveis, sem hepatomegalia ou esplenomegalia. Esfregaço: linfócitos pequenos, de cromatina condensada, com numerosas células esmagadas. LDH e função renal normais. O próximo exame mais adequado é:

A) Imunofenotipagem do sangue periférico

B) Repetir hemograma em 4 semanas

C) Biópsia de medula óssea

D) TC de tórax, abdome e pelve

---

3 Homem de 71 anos, com diabetes tipo 2 há 22 anos (HbA1c 8,9%), retinopatia proliferativa e parestesias em bota, e hipertensão tratada com hidroclorotiazida 25 mg e losartana 50 mg, relata tontura ao se levantar, pior pela manhã e após o almoço, com duas quedas no último mês. Nega vômitos, diarreia ou redução da ingestão de líquidos; peso estável. Sem tremor, rigidez, bradicinesia ou ataxia; sem uso de alfabloqueador. Deitado há 5 minutos: PA 168×94 mmHg e FC 74 bpm. Após 3 minutos em pé: PA 126×78 mmHg e FC 77 bpm. Ureia 36 mg/dL, creatinina 1,0 mg/dL (igual à de 6 meses atrás), sódio 138 mEq/L, potássio 4,2 mEq/L, glicemia 164 mg/dL, Hb 13,6 g/dL. A filha atribui as quedas 'ao diurético, que desidrata'. A causa mais provável da hipotensão ortostática é:

A) Insuficiência adrenal primária

B) Atrofia de múltiplos sistemas

C) Depleção de volume pelo tiazídico

D) Neuropatia autonômica diabética

---

4 Homem de 66 anos, com mieloma múltiplo IgA kappa diagnosticado há 1 semana e quimioterapia ainda não iniciada, é trazido por cefaleia, visão turva, epistaxe recorrente e sonolência há 2 dias. PA 150×90 mmHg, FC 96 bpm, SatO2 95%, sem dispneia, sem dor torácica, sem estertores. Fundoscopia: veias retinianas dilatadas e tortuosas, com hemorragias em chama de vela. Exames: Hb 6,8 g/dL, plaquetas 110.000/mm³, creatinina 1,6 mg/dL, cálcio corrigido 10,2 mg/dL, proteínas totais 12,4 g/dL, componente monoclonal IgA de 6,8 g/dL, hemácias empilhadas no esfregaço. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Plasmaférese antes de qualquer transfusão

B) Transfusão de dois concentrados de hemácias

C) Dexametasona em dose alta isolada

D) Hemodiálise com filtro de alto ponto de corte

---

5 Homem de 74 anos, em situação de rua, é encontrado inconsciente e molhado numa madrugada de inverno. A equipe constata ausência de pulso, com fibrilação ventricular no monitor; temperatura esofágica de 26 °C. Recebeu três choques sem sucesso e está em RCP de alta qualidade há 40 minutos, sem retorno da circulação. Não há trauma, rigidez nem lesão incompatível com a vida. Gasometria: pH 7,08, potássio 5,4 mEq/L (ref. 3,5 a 5,0). Há hospital com ECMO a 25 minutos. A conduta mais adequada é:

A) Encerrar a reanimação pelo tempo

B) Manter RCP e transferir para ECMO

C) Novos choques e amiodarona a cada ciclo

D) Adrenalina a cada 3 a 5 minutos

---

6 Mulher de 64 anos teve vasculite crioglobulinêmica pela hepatite C, com púrpura e artralgia, e foi tratada com sofosbuvir e velpatasvir há 2 anos, com RNA do HCV indetectável 12 semanas após o fim do tratamento e em duas dosagens posteriores; a púrpura desapareceu na época. Há 3 meses voltou a ter púrpura palpável nas pernas e artralgia de mãos e, há 3 semanas, pé caído à direita e parestesia dolorosa na mão esquerda. Nega uso de drogas injetáveis, nova parceria sexual e procedimentos invasivos. Exame físico: PA 132 × 80 mmHg, púrpura palpável em pernas, fraqueza da dorsiflexão do pé direito, hipoestesia no território do ulnar esquerdo, sem linfonodomegalias e sem esplenomegalia. Exames: creatinina 0,8 mg/dL, urina sem hematúria ou proteinúria, C4 4 mg/dL (VR 10 a 40), fator reumatoide 410 UI/mL, crioglobulinas positivas com criócrito de 5%, RNA do HCV indetectável hoje, HBsAg e anti-HIV não reagentes, LDH normal. Eletroneuromiografia: mononeuropatia múltipla axonal. A conduta mais adequada é:

A) Prednisona isoladamente

B) Plasmaférese isoladamente

C) Rituximabe com glicocorticoide

D) Novo ciclo de antiviral de ação direta

---

7 Homem de 34 anos, no oitavo dia de internação por traumatismo cranioencefálico (contusão frontal, sem cirurgia), em uso de levetiracetam e dieta enteral. O sódio caiu de 138 para 129 mEq/L em quatro dias, e a equipe, suspeitando de perda cerebral de sal, iniciou salina a 0,9% a 125 mL/h. Após 24 horas e 3 L de salina, o sódio está em 126 mEq/L e o paciente ficou mais sonolento, sem convulsões. Peso 0,8 kg acima do da véspera, balanço hídrico positivo de 900 mL no período, FC 76 bpm, PA 128/80 mmHg, sem hipotensão postural, hematócrito de 40% para 39%, ureia 18 mg/dL. Osmolalidade plasmática 262 mOsm/kg, osmolalidade urinária 610 mOsm/kg, sódio urinário 168 mEq/L, potássio urinário 44 mEq/L, ácido úrico 2,4 mg/dL, cortisol e TSH normais. O mecanismo da hiponatremia e a conduta são, respectivamente:

A) SIADH / salina a 3%, sem mais isotônica

B) Perda cerebral de sal / mais salina a 0,9%

C) SIADH / restrição hídrica isolada

D) Perda cerebral de sal / fludrocortisona

---

8 Mulher de 38 anos, com hemorragia subaracnóidea aneurismática e herniação documentada em TC, está em ventilação mecânica há 30 horas, sem sedativo há 26 horas (midazolam em infusão apenas nas 4 primeiras horas, função renal e hepática normais). Temperatura esofágica 36,4 °C, PAM 78 mmHg com noradrenalina em dose baixa, SatO2 98%, sódio 152 mEq/L, glicemia 164 mg/dL. Foi aberto o protocolo de morte encefálica: no primeiro exame clínico, coma aperceptivo, pupilas médias e fixas, ausência dos reflexos fotomotor, corneopalpebral, oculocefálico, vestibulocalórico e de tosse. Ao estímulo doloroso no leito ungueal do hálux, observa-se flexão tripla do membro inferior estimulado, com sudorese no tronco; o estímulo supraorbitário não provoca resposta. A família foi informada pela enfermagem de que 'ela mexeu a perna'. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Interromper o protocolo e reavaliar em 24 horas

B) Prosseguir com o teste de apneia

C) Corrigir o sódio antes de prosseguir

D) Fazer eletroencefalograma antes da apneia

---

9 Na hemorragia digestiva alta aguda do adulto, segundo o maior ensaio clínico randomizado sobre o tema, o ácido tranexâmico intravenoso em dose alta:

A) Está indicado se a endoscopia atrasar

B) Não reduz mortalidade e aumenta trombose

C) Está indicado só na hemorragia varicosa

D) Deve ser dado antes da endoscopia

---

10 Mulher de 67 anos, diabética e com DPOC, procura a emergência em julho, no 4º dia de febre de 38,8 °C, mialgia intensa, cefaleia e tosse seca. Duas pessoas da casa tiveram quadro parecido na semana anterior. Exame: T 38,4 °C, FR 26 irpm, SpO2 89% em ar ambiente, PA 128 × 74 mmHg, estertores finos em bases. Radiografia de tórax: infiltrado intersticial bilateral discreto. Será internada com oxigênio. O swab nasofaríngeo para RT-PCR de vírus respiratórios foi colhido, com resultado previsto em 48 horas. Quanto ao oseltamivir, a indicação e o momento de início são, respectivamente:

A) Indicado / após o resultado do RT-PCR

B) Não indicado / fora da janela de 48 horas

C) Não indicado / apenas se RT-PCR positivo

D) Indicado / imediatamente, sem esperar

---

11 Homem de 78 anos, com diabetes tipo 2 há 15 anos em uso de metformina 1.000 mg/dia e gliclazida MR 60 mg/dia (HbA1c recente de 7,1%), hipertensão e doença renal crônica com TFGe de 38 mL/min/1,73 m², foi atendido na UPA há 4 dias por tosse produtiva, febre e consolidação em base direita, com CURB-65 de 1, e recebeu alta com um antibiótico oral em dose única diária, em monoterapia, escolhido porque ele é alérgico a penicilina. Desde ontem teve três episódios de sudorese e confusão de madrugada, com glicemias capilares de 42, 38 e 47 mg/dL, revertidos com glicose oral. Não mudou a alimentação nem as doses. Hoje: afebril, PA 132 × 78 mmHg, FC 84 bpm, SpO2 95%. Exames: creatinina 1,7 mg/dL (basal de 1,6 mg/dL), sódio 138 mEq/L, potássio 4,4 mEq/L, cortisol às 8 horas 19 µg/dL, ECG com QTc de 488 ms. A causa mais provável das hipoglicemias é:

A) Acúmulo da metformina pela TFG baixa

B) Insuficiência adrenal relativa da infecção

C) Fluoroquinolona somada à sulfonilureia

D) Acúmulo da gliclazida por piora renal

---

12 Mulher de 52 anos, com diabetes tipo 2 mal controlado (HbA1c 9,1%) e obesidade, é internada com dor epigástrica em faixa há 12 horas e vômitos. Iniciou estradiol oral há 2 meses para fogachos. Não ingere álcool. PA 124×80 mmHg, FC 104 bpm. Exames: lipase 2.900 U/L (referência até 60), amilase 140 U/L (referência até 100), ALT 38 U/L, AST 40 U/L, bilirrubina 0,7 mg/dL, fosfatase alcalina normal, cálcio 8,6 mg/dL, glicemia 286 mg/dL, soro de aspecto leitoso e triglicerídeos de 2.840 mg/dL. Ultrassonografia: vesícula com múltiplos cálculos de 5 a 8 mm e colédoco de 5 mm. A etiologia mais provável da pancreatite é:

A) Pancreatite autoimune

B) Hipertrigliceridemia

C) Toxicidade pancreática direta do estrogênio

D) Litíase biliar

---

13 Homem de 52 anos, tabagista e dislipidêmico, chega ao pronto-socorro com dor retroesternal opressiva, irradiada para a mandíbula, iniciada há 50 minutos, com sudorese fria. PA 148×92 mmHg, FC 94 bpm, SpO2 96%, pulmões limpos, sem sopros. ECG da chegada: ritmo sinusal, QRS estreito, infradesnivelamento ascendente do ponto J de 2 mm de V2 a V5, seguido de ondas T altas, simétricas e apiculadas nas mesmas derivações, e supradesnivelamento de 1 mm em aVR; nenhuma derivação com supradesnivelamento do ST em 2 derivações contíguas. Troponina T ultrassensível da chegada: 9 ng/L (referência até 14 ng/L). O hospital tem hemodinâmica 24 horas, com tempo previsto até a passagem do fio de 40 minutos. O plantonista registra 'SCA sem supra de ST, troponina negativa: repetir em 1 hora'. Além de AAS e anticoagulação, a conduta mais adequada neste momento é:

A) Fibrinólise com tenecteplase

B) Cateterismo nas primeiras 24 horas

C) Troponina seriada em 1 hora

D) Angioplastia primária imediata

---

14 Homem de 24 anos, militar em alojamento coletivo, procura atendimento por dor e edema articulares há 9 dias. Três semanas antes teve faringite febril tratada apenas com sintomáticos. A dor começou no joelho direito, passou ao tornozelo esquerdo e depois ao punho direito, cada articulação melhorando em poucos dias, com alívio rápido após iniciar naproxeno. Nega uretrite, diarreia, lesões de pele e dor lombar. Exame físico: Tax 37,9 °C, FC 104 bpm, PA 122 × 70 mmHg; bulhas normofonéticas, sem sopros e sem atrito pericárdico; artrite do punho direito. Exames: VHS 84 mm/h, PCR 96 mg/L, antiestreptolisina O 820 UI/mL (VR até 200), ECG com ritmo sinusal e intervalo PR de 0,22 s. O exame mais importante para definir a conduta neste momento é:

A) Nenhum exame adicional

B) Cultura de orofaringe

C) Ressonância magnética cardíaca

D) Ecocardiograma transtorácico com Doppler

---

15 Mulher de 61 anos com adenocarcinoma de mama metastático, em quimioterapia, ECOG 1, tem derrame pleural direito com citologia oncótica positiva, em terceira recidiva sintomática em 5 semanas. Na toracocentese de alívio, após retirar 1.100 mL, surgiram tosse e desconforto torácico; a manometria mostrou queda da pressão pleural de -2 para -24 cmH2O. A radiografia logo após mostra hidropneumotórax pequeno, com o pulmão sem reexpandir e pleura visceral espessada; não houve fístula, e a paciente segue estável. Expectativa de vida estimada em vários meses. A interpretação do achado e a conduta definitiva mais adequada são, respectivamente:

A) Pulmão expansível / pleurodese com talco

B) Pulmão encarcerado / pleurodese com talco

C) Pulmão expansível / cateter pleural tunelizado

D) Pulmão encarcerado / cateter pleural tunelizado

---

16 Homem de 74 anos, ex-tabagista (45 maços-ano, parou há seis anos), com fosfatase alcalina entre 380 e 450 U/L (até 129) nos últimos cinco anos, nunca investigada, e queixa antiga de que os chapéus não lhe servem mais. Há três semanas sofreu fratura de colo de fêmur, operada, e desde então está restrito ao leito por delirium e dor. Agora com poliúria, constipação e piora da sonolência. Exames: cálcio total 12,9 mg/dL (albumina 3,8 g/dL), fósforo 4,3 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL (era 0,9), fosfatase alcalina 1.240 U/L, PTH 7 pg/mL (15 a 65), PTHrP indetectável, 25-hidroxivitamina D 31 ng/mL, 1,25-di-hidroxivitamina D 18 pg/mL (18 a 72), eletroforese de proteínas e cadeias leves livres normais. Radiografia de tórax sem nódulos. Cintilografia óssea: captação intensa e homogênea em toda a hemipelve direita e na calota craniana, sem outros focos. A causa mais provável da hipercalcemia é:

A) Metástases ósseas de carcinoma de pulmão

B) Hiperparatireoidismo primário

C) Hipercalcemia humoral por carcinoma escamoso

D) Imobilização sobre doença de Paget

---

17 Mulher de 29 anos, em uso de anticoncepcional oral combinado há 3 anos, tem há 3 semanas dor em hipocôndrio direito e aumento do volume abdominal. Nega etilismo. Exame: PA 112×70 mmHg, jugulares não túrgidas, hepatomegalia dolorosa, ascite moderada, sem encefalopatia ou asterixe. Exames: ALT 310 U/L, AST 280 U/L, bilirrubina 2,1 mg/dL, INR 1,4, albumina 3,2 g/dL, plaquetas 310.000/mm³, creatinina 0,8 mg/dL. Líquido ascítico com gradiente soro-ascite de 1,6 g/dL e proteína de 3,4 g/dL. Doppler: trombos oclusivos nas veias hepáticas média e direita, fluxo reduzido na esquerda, veia porta pérvia e veia cava sem estenose segmentar. Foram colhidas pesquisa de JAK2 e de trombofilias. Além de suspender o anticoncepcional, a conduta inicial mais adequada é:

A) Avaliação para transplante hepático

B) Trombólise sistêmica

C) Anticoagulação plena imediata

D) TIPS de urgência

---

18 Homem de 28 anos, jardineiro em Petrópolis, foi picado na mão direita há 2 horas por uma serpente pequena, de anéis vermelhos, pretos e brancos, ao remexer folhas. O vizinho, que mora na roça há 40 anos, matou o animal e garantiu que era coral-falsa, porque "os anéis não fecham na barriga". O paciente refere apenas parestesia discreta no local. Exame: PA 126 × 80 mmHg, FC 84 bpm, FR 18 irpm, SpO2 97%. Na mão, duas pequenas marcas puntiformes, sem edema, sem equimose e sem bolhas. Ao exame neurológico, ptose palpebral bilateral, que ele atribui ao sono, e queixa de visão turva para longe; força nos membros preservada. Tempo de coagulação normal. Não há serviço de herpetologia para identificar o animal. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Soro antielapídico, 10 ampolas IV

B) Observação por 24 horas, sem soro

C) Neostigmina isolada, sem soro

D) Soro antibotrópico-crotálico IV

---

19 Mulher de 44 anos, professora, é encaminhada ao ambulatório de neurologia com laudo de 'provável doença desmielinizante'. Tem migrânea com aura visual desde os 25 anos e, nos últimos 2 anos, teve dois episódios de hemiparesia direita leve com recuperação em semanas, além de depressão em uso de sertralina. Nega tabagismo; PA 122/78 mmHg, LDL 98 mg/dL, glicemia normal. O pai teve 'derrames de repetição' a partir dos 48 anos e morreu com demência aos 59; um tio paterno teve quadro semelhante. Exame: leve hiper-reflexia à direita, sem outros achados. RM de encéfalo: hiperintensidades confluentes em T2/FLAIR na substância branca periventricular, nas cápsulas externas e nos polos temporais anteriores, com infartos lacunares antigos e micro-hemorragias, sem realce pelo gadolínio. Líquor sem bandas oligoclonais. Ecocardiograma transtorácico e angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos normais. O próximo exame mais adequado é:

A) Anticorpo anti-aquaporina-4 sérico

B) Ecocardiograma transesofágico com microbolhas

C) Pesquisa de variante patogênica no NOTCH3

D) Angiografia cerebral digital

---

20 Homem de 31 anos, HIV negativo, sem comorbidades, procura atendimento por dor em fossa ilíaca direita e aumento do volume abdominal há 3 semanas. TC de abdome: massa ileocecal de 11 cm, com ascite moderada. Exames: LDH 2.900 U/L, ácido úrico 9,8 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL, potássio 5,1 mEq/L. Biópsia da massa: infiltração difusa por células de tamanho médio e monomórficas, com numerosos macrófagos de citoplasma claro entremeados. Imuno-histoquímica: CD20+, CD10+, BCL6+, BCL2 negativo, TdT negativo, Ki-67 de 99%. A alteração genética esperada neste tumor é:

A) Rearranjo de MYC, t(8;14)

B) Rearranjo de BCL2, t(14;18)

C) Rearranjo de CCND1, t(11;14)

D) Fusão BCR-ABL1, t(9;22)

---

21 Mulher de 26 anos tem diagnóstico de diabetes tipo 1 desde os 17 anos, feito por glicemia de 290 mg/dL sem cetoacidose, e usa insulina glargina 10 U/dia e asparte 3 a 4 U por refeição. Relata hipoglicemias frequentes mesmo com essas doses e HbA1c de 7,9%. A mãe teve diabetes aos 22 anos, tratada por muitos anos só com glibenclamida, e o avô materno também era diabético; nenhum deles é obeso. IMC 21 kg/m², sem acantose. Exames: anti-GAD, anti-IA2 e anti-ZnT8 negativos; peptídeo C de 1,8 ng/mL com glicemia simultânea de 160 mg/dL; glicosúria 3+ com glicemia de 140 mg/dL; PCR ultrassensível de 0,2 mg/L. O sequenciamento genético mostrou variante patogênica no gene HNF1A. A conduta mais adequada é:

A) Gliclazida em dose baixa, suspendendo a insulina

B) Insulina basal isolada, sem os bolus

C) Manter o basal-bolus com doses menores

D) Metformina, suspendendo a insulina

---

22 Mulher de 31 anos, no 9º dia após parto vaginal sem intercorrências, chega ao pronto-socorro com dor súbita em hipocôndrio esquerdo e ombro esquerdo há 3 horas, com sudorese e tontura. Antecedentes: perfuração espontânea do sigmoide aos 24 anos, pneumotórax espontâneo aos 19, equimoses fáceis desde a infância e pé torto congênito; a mãe morreu aos 38 anos de 'hemorragia interna sem causa'. Ao exame: 1,61 m, envergadura igual à altura, face magra com nariz afilado e lábios finos, pele fina e translúcida, com a rede venosa visível no tórax e no abdome; pele sem hiperextensibilidade e grandes articulações com mobilidade normal; exame oftalmológico na gestação sem subluxação do cristalino. PA 90×56 mmHg e FC 120 bpm na chegada; após 1 litro de cristaloide e 2 concentrados de hemácias, PA 108×66 mmHg e FC 102 bpm. Hb 7,9 g/dL. Ultrassonografia à beira do leito: líquido livre perisplênico e na pelve; ecocardiograma focado com raiz aórtica de 31 mm e sem derrame pericárdico. A lesão vascular mais provável e o exame de imagem mais adequado para confirmá-la são, respectivamente:

A) Dissecção aórtica por dilatação da raiz / angiotomografia

B) Rotura de artéria visceral de médio calibre / arteriografia por cateter

C) Rotura de artéria visceral de médio calibre / angiotomografia

D) Dissecção aórtica por dilatação da raiz / arteriografia por cateter

---

23 Na febre familiar do Mediterrâneo, o tratamento de base e a complicação a longo prazo que ele previne são, respectivamente:

A) Colchicina contínua / amiloidose AA

B) Colchicina contínua / amiloidose AL

C) Colchicina nas crises / amiloidose AA

D) Prednisona nas crises / amiloidose AA

---

24 Homem de 58 anos, diabético em uso de metformina, tem tosse seca há 7 semanas, febre vespertina e perda de 6 kg. Anti-HIV não reagente. Radiografia de tórax: opacidade heterogênea no ápice direito com pequena cavidade. Uma amostra de escarro colhida na primeira consulta, de pouco volume e aspecto salivar, teve baciloscopia negativa; desde então ele não consegue expectorar, apesar de orientado. TC de tórax: cavidade de 2 cm e nódulos centrolobulares em árvore em brotamento no lobo superior direito. SpO2 96% em ar ambiente, sem hemoptise. O próximo exame mais adequado é:

A) Broncoscopia com lavado broncoalveolar

B) Prova tuberculínica

C) Escarro induzido para TRM-TB e cultura

D) Biópsia transbrônquica

---

25 Mulher de 58 anos desenvolveu, em 6 semanas, ataxia de marcha e de membros, disartria e nistagmo, até ficar restrita à cadeira de rodas. Ressonância de crânio normal; líquor com 12 linfócitos/mm³ e bandas oligoclonais; anticorpo anti-Yo (anti-PCA1) fortemente positivo. A investigação achou carcinoma seroso de ovário em estádio inicial, ressecado com margens livres, seguido de quimioterapia adjuvante; recebeu também metilprednisolona e imunoglobulina intravenosa. Três meses depois, CA-125 normalizado e sem doença residual na imagem. Em relação ao quadro neurológico, a evolução mais esperada é:

A) Melhora paralela à queda do CA-125

B) Surtos com remissão completa entre eles

C) Estabilização com déficit grave persistente

D) Recuperação completa com a ressecção do tumor

---

26 Homem de 36 anos, com aids diagnosticada há 1 mês (CD4 38 células/mm³, ainda sem TARV), apresentou cefaleia, febre baixa e hemiparesia direita progressivas em 10 dias. RM de crânio: três lesões com realce anelar e edema perilesional, em núcleos da base e na junção córtico-subcortical, sem contato com o epêndima. IgG anti-Toxoplasma reagente. Iniciados sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Uma punção lombar, feita após a imagem por não haver desvio de linha média, mostrou 12 células/mm³, proteína de 68 mg/dL, PCR para Toxoplasma gondii negativa e PCR para vírus Epstein-Barr positiva. No 14º dia de tratamento, a hemiparesia regrediu quase por completo, e a nova RM mostra redução de mais de 50% do volume das lesões. O diagnóstico mais provável é:

A) Linfoma primário do SNC

B) Neurotoxoplasmose

C) Linfoma e toxoplasmose concomitantes

D) Leucoencefalopatia multifocal progressiva

---

27 Homem de 58 anos, etilista, com hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal, chega em choque. Nas primeiras 3 horas recebe, pelo protocolo de transfusão maciça, 10 unidades de concentrado de hemácias, 8 de plasma fresco congelado e 1 dose de plaquetas, além de pantoprazol, e aguarda a endoscopia. Apesar disso, mantém PA 82 × 48 mmHg e FC 118 bpm, com noradrenalina em dose crescente, extremidades frias e QTc de 520 ms no monitor. Não há saída de sangue pela sonda nasogástrica nos últimos 40 minutos. Exames colhidos agora: Hb 8,9 g/dL, plaquetas 92.000/mm³, INR 1,4, fibrinogênio 190 mg/dL, lactato 4,1 mmol/L, potássio 4,6 mEq/L, cálcio iônico 0,78 mmol/L (VR 1,12 a 1,32), temperatura 35,4 °C. Além do aquecimento ativo, a medida mais adequada neste momento é:

A) Crioprecipitado, 10 unidades

B) Nova unidade de concentrado de hemácias

C) Cloreto de cálcio intravenoso

D) Mais 4 unidades de plasma

---

28 Homem de 68 anos, com diabetes tipo 2 há 20 anos, doença renal do diabetes com clearance de creatinina estimado de 24 mL/min e episódio depressivo leve diagnosticado há 1 mês, queixa-se de queimação e choques nos pés há 8 meses, piores à noite, que atrapalham o sono. Usa insulina NPH e regular, losartana, anlodipino e atorvastatina; tem hiperplasia prostática com jato fraco e glaucoma de ângulo fechado em acompanhamento. HbA1c 7,4%, B12 e TSH normais. Exame: hipoestesia em bota, aquileus abolidos, pulsos pediosos presentes, sem úlceras. ECG: bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Para a dor neuropática, a melhor opção inicial é:

A) Pregabalina 75 mg/dia

B) Duloxetina 60 mg/dia

C) Amitriptilina 25 mg à noite

D) Sertralina 50 mg/dia

---

29 Homem de 52 anos, transplantado renal de doador falecido há nove meses, em uso de tacrolimo (vale de 7,8 ng/mL, alvo de 6 a 8), micofenolato de mofetila 1 g de 12/12 horas e prednisona 5 mg/dia. A creatinina subiu de 1,3 para 2,0 mg/dL em seis semanas, sem febre, com urina sem cilindros hemáticos e ultrassonografia sem hidronefrose. Anticorpos anti-HLA específicos do doador negativos. PCR para poliomavírus BK no plasma de 25.000 cópias/mL. A biópsia do enxerto mostra infiltrado intersticial com tubulite moderada, C4d negativo e imuno-histoquímica para SV40 positiva em núcleos de células tubulares. A conduta mais adequada é:

A) Reduzir ou suspender o micofenolato

B) Pulsoterapia com metilprednisolona

C) Cidofovir intravenoso em dose baixa

D) Globulina antitimocitária

---

30 Mulher de 49 anos, hipertensa e obesa (IMC 36 kg/m²), fez ressonância de crânio para investigar cefaleia tensional de longa data, que melhorou com amitriptilina. O laudo descreve sela túrcica parcialmente vazia, com haste centrada e hipófise de 3 mm rechaçada contra o assoalho, sem lesões. Está na menopausa há 2 anos, amamentou os dois filhos sem dificuldade e não tem fadiga, poliúria, galactorreia nem alteração visual. PA 138 × 86 mmHg, FC 76 bpm; fundoscopia sem papiledema e campos visuais normais à confrontação. Sódio 139 mEq/L, glicemia 98 mg/dL. Ela traz o laudo preocupada com um tumor. O passo mais adequado é:

A) Avaliação hormonal basal da hipófise

B) Nova ressonância de sela em 12 meses

C) Campimetria computadorizada seriada

D) Punção lombar com manometria

---

31 Mulher de 81 anos, com doença de Alzheimer leve e glaucoma de ângulo aberto, é trazida por tonturas há 3 semanas e um episódio de lipotimia ao caminhar. A filha conta que há 2 meses o neurologista iniciou um comprimido 'para a memória', com aumento da dose há 3 semanas, e que o oftalmologista mantém há anos um colírio que reduz a pressão do olho e que 'não pode ser usado por quem tem asma'. Usa também anlodipino 5 mg. PA 134×72 mmHg, FC 42 bpm, regular. ECG: bradicardia sinusal de 42 bpm, PR 190 ms, QRS 90 ms. Holter de 24 horas: FC mínima de 36 bpm em vigília, pausas sinusais de até 2,6 segundos, sem bloqueio atrioventricular. TSH 2,4 mUI/L, potássio 4,3 mEq/L, troponina normal. A conduta mais adequada é:

A) Estudo eletrofisiológico da função sinusal

B) Atropina e marca-passo transcutâneo

C) Implante de marca-passo definitivo

D) Retirar as drogas bradicardizantes e reavaliar

---

32 Homem de 71 anos, com doença renal crônica estágio 3b e cardiopatia isquêmica em uso de AAS, é internado com hematêmese volumosa e melena; PA 88×50 mmHg, FC 118 bpm. Após ressuscitação, faz endoscopia em 10 horas: grande quantidade de sangue fresco e coágulos em fundo e corpo gástricos, removidos parcialmente com lavagem; na mucosa visível, sem úlcera, varizes, erosões ou neoplasia; duodeno até a segunda porção normal. Estabiliza com 3 concentrados de hemácias. Trinta horas depois, nova hematêmese com queda da hemoglobina de 8,9 para 6,7 g/dL e PA 92×56 mmHg, que responde a volume. Colonoscopia há 1 ano normal. O próximo exame mais adequado é:

A) Angiotomografia abdominal

B) Nova endoscopia digestiva alta

C) Cápsula endoscópica do delgado

D) Colonoscopia após preparo

---

33 Mulher de 72 anos, previamente hígida, tem polimialgia reumática diagnosticada há 7 meses, iniciada com prednisona 15 mg/dia e reduzida gradualmente, com remissão completa. Há 10 dias, 2 semanas após passar de 7,5 mg para 5 mg/dia, voltou a ter dor e rigidez matinal de 1 hora em cinturas escapular e pélvica. Nega cefaleia, alteração visual, claudicação de mandíbula ou de membros, febre e perda de peso. Usa cálcio e vitamina D. Exame físico: dor à mobilização ativa dos ombros, artérias temporais pulsáteis e indolores, pulsos e pressão arterial simétricos nos membros superiores. VHS 44 mm/h (era 12 mm/h), PCR 18 mg/L. É a primeira recaída. A conduta inicial mais adequada é:

A) Prednisona de volta a 15 mg/dia

B) Prednisona de volta a 7,5 mg/dia

C) Manter 5 mg e associar naproxeno

D) Pulso de metilprednisolona

---

34 Mulher de 29 anos, com hemoglobinúria paroxística noturna, recebe eculizumabe a cada 14 dias há 2 anos. Recebeu as vacinas meningocócicas ACWY e B antes do início do tratamento, com reforços em dia. Procura o pronto-socorro 6 horas após o início de febre de 38,9 °C, calafrios e mialgia intensa nas pernas. PA 104 × 62 mmHg, FC 112 bpm, FR 20 irpm, sem rigidez de nuca, sem petéquias, sem foco infeccioso aparente. Leucócitos 14.800/mm³ com desvio à esquerda, Hb 10,1 g/dL (estável), urina sem hemoglobinúria. Teste rápido para influenza negativo. A conduta mais adequada é:

A) Antecipar a dose de eculizumabe

B) Hemoculturas e aguardar resultado

C) Sintomáticos e reavaliação em 24 h

D) Hemoculturas e ceftriaxona imediata

---

35 Mulher de 32 anos, sem comorbidades, está no 5º dia de dengue confirmada por NS1. Chegou à emergência com extremidades frias, enchimento capilar de 4 segundos, PA 84 × 70 mmHg e FC 126 bpm; hematócrito de 50% e plaquetas de 34.000/mm³. Recebeu três bolus de 20 mL/kg de cristaloide em 1 hora, com diurese de 0,3 mL/kg/h. Na reavaliação: PA 80 × 60 mmHg, FC 132 bpm, extremidades ainda frias, sem sangramento exteriorizado, sem melena ao toque retal; o novo hematócrito caiu para 36%, e as plaquetas são 18.000/mm³. RNI 1,4, fibrinogênio 160 mg/dL. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Albumina 0,5 a 1 g/kg IV

B) Quarto bolus de cristaloide 20 mL/kg

C) Concentrado de hemácias 10 a 15 mL/kg

D) Transfusão de concentrado de plaquetas

---

36 Gestante de 26 anos, com 31 semanas, asmática, chega com crise há 10 horas, sem melhora após três ciclos de salbutamol inalatório. Está consciente, fala frases curtas e usa musculatura acessória. FR 30 irpm, FC 118 bpm, SpO2 93% em ar ambiente; sibilos difusos de intensidade reduzida. Pico de fluxo 45% do melhor valor pessoal. Gasometria arterial em ar ambiente: pH 7,40, PaCO2 40 mmHg, PaO2 68 mmHg, HCO3 24 mEq/L. A interpretação mais adequada da gasometria é:

A) Alcalose respiratória esperada da gestação

B) Retenção de CO2 com fadiga iminente

C) Acidose metabólica associada à crise

D) Gasometria normal, sem gravidade adicional

---

37 Homem de 63 anos, hipertenso em uso de losartana, é internado por 'epilepsia focal refratária'. Há 6 semanas tem episódios de 1 a 2 segundos de contração tônica do braço e da hemiface esquerdos, às vezes com a perna, até 60 vezes por dia, sem perda de consciência; há 3 semanas, a esposa nota esquecimento de fatos recentes e irritabilidade. Já usou levetiracetam e carbamazepina em doses plenas, sem redução dos episódios. Afebril, PA 132/80 mmHg, sem déficit focal entre os episódios. Sódio 127 mEq/L (antes do início da carbamazepina, 129 mEq/L), osmolalidade urinária 410 mOsm/kg, TSH e cortisol normais. EEG interictal normal; um episódio registrado sem correlato eletrográfico claro. RM: discreto hipersinal em T2/FLAIR no hipocampo direito. Líquor: 3 células/mm³, proteína 48 mg/dL. O diagnóstico mais provável é:

A) Crises por hiponatremia da carbamazepina

B) Epilepsia temporal por esclerose hipocampal

C) Doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica

D) Encefalite autoimune anti-LGI1

---

38 Homem de 24 anos, com cálculos renais desde os 14 anos (cinco episódios de cólica e duas ureterolitotripsias), pai e um irmão também litiásicos. A análise de um cálculo expelido identificou cistina. Há oito meses segue ingestão hídrica de 4 L/dia, dieta com restrição de sódio (sódio urinário de 95 mEq/dia) e citrato de potássio em dose plena. Nova tomografia sem contraste mostra dois cálculos novos, de 6 e 8 mm, no rim esquerdo. Urina de 24 horas: volume 3,6 L, cistina 720 mg/dia, cálcio 180 mg/dia, citrato 820 mg/dia; pH urinário de 7,6 em três medidas domiciliares. Creatinina 0,9 mg/dL, potássio 4,6 mEq/L. Além de manter as medidas atuais, a conduta mais adequada para prevenir novos cálculos é:

A) Elevar o citrato até pH acima de 8,0

B) Associar acetazolamida à noite

C) Associar tiopronina oral

D) Associar hidroclorotiazida em dose baixa

---

39 Mulher de 47 anos refere aumento progressivo do pescoço há 10 meses, com rouquidão há 2 meses e dispneia ao deitar. Há 3 anos fez nefrostomia bilateral por hidronefrose causada por fibrose retroperitoneal, em acompanhamento. Exame: tireoide aumentada de forma difusa, pétrea, indolor, aderida aos planos profundos e sem mobilidade à deglutição; sem linfonodos palpáveis; afebril. TSH 7,8 mUI/L, T4 livre 0,9 ng/dL (referência 0,9 a 1,8), anti-TPO 210 UI/mL (referência até 35), VHS 32 mm/h. Duas punções aspirativas foram não diagnósticas por material acelular. A biópsia incisional mostrou fibrose densa hialinizada que ultrapassa a cápsula e invade a musculatura pré-tireoidiana, flebite oclusiva e infiltrado linfoplasmocitário com mais de 30 plasmócitos IgG4 positivos por campo, sem atipias. O diagnóstico e o tratamento clínico de primeira linha são, respectivamente:

A) Hashimoto fibrosante / levotiroxina

B) Tireoidite de Riedel / prednisona

C) Carcinoma anaplásico / quimiorradioterapia

D) Linfoma primário da tireoide / R-CHOP

---

40 Homem de 69 anos, ex-tabagista, recebeu há 8 meses diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática por tomografia com padrão de pneumonia intersticial usual, sem biópsia, e aguarda o início de antifibrótico. Nega exposição a aves, mofo, poeiras ocupacionais, amiodarona e nitrofurantoína; sem Raynaud, artrite, lesões de pele ou fraqueza. Há 2 meses tem astenia, perda de 5 kg e febre baixa vespertina. Exame físico: PA 152 × 90 mmHg, estertores em velcro em bases, sem baqueteamento digital. Exames: Hb 10,4 g/dL, creatinina 1,9 mg/dL (0,9 mg/dL há 8 meses), urina tipo 1 com 40 hemácias por campo, 70% dismórficas, e proteína 2+; PCR 64 mg/L; FAN e fator reumatoide não reagentes. O exame a solicitar agora é:

A) Biópsia pulmonar cirúrgica

B) Lavado broncoalveolar com celularidade

C) ANCA com anti-MPO e anti-PR3

D) Ultrassonografia renal com Doppler

---

41 Gestante de 31 anos, G2P1, com 33 semanas, refere prurido intenso em palmas e plantas há 2 semanas, pior à noite, sem lesões cutâneas além de escoriações. Nega náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia ou polidipsia. PA 118×72 mmHg. Exames: ALT 186 U/L, AST 140 U/L, bilirrubina total 1,4 mg/dL, plaquetas 228.000/mm³, glicemia 82 mg/dL, creatinina 0,6 mg/dL, ácido úrico 4,1 mg/dL, INR 1,0, proteinúria negativa e ácidos biliares séricos totais de 118 µmol/L. Sorologias para hepatites virais negativas. Ultrassonografia: vesícula com microcálculos, vias biliares não dilatadas. O diagnóstico e a programação do parto são, respectivamente:

A) Esteatose hepática aguda da gestação / parto imediato

B) Colestase intra-hepática da gestação / parto com 38 a 39 semanas

C) Síndrome HELLP / parto com 34 semanas

D) Colestase intra-hepática da gestação / parto entre 35 e 36 semanas

---

42 Homem de 41 anos, negro, assintomático, procura o cardiologista porque o pai, de 68 anos, acaba de receber o diagnóstico de amiloidose cardíaca por transtirretina: cintilografia com pirofosfato grau 3, imunofixação sérica e urinária negativas, cadeias leves livres normais e sequenciamento do gene TTR heterozigoto para a variante Val142Ile (antiga V122I). O pai operou túnel do carpo aos 58 anos e tem dispneia desde os 64. O paciente corre 5 km três vezes por semana e nega parestesias, dormência nas mãos, diarreia, tontura ao levantar ou dispneia. PA 124×78 mmHg, FC 62 bpm, exame físico normal. ECG: ritmo sinusal, voltagem normal, sem áreas inativas. Ecocardiograma: septo de 9 mm, FE 63%, strain longitudinal global normal e sem preservação apical. NT-proBNP 36 pg/mL. O médico do convênio sugere 'cintilografia com pirofosfato já, para pegar a doença no início'. O próximo exame mais adequado é:

A) Ressonância cardíaca com mapa T1

B) Teste genético dirigido à variante paterna

C) Nenhum exame enquanto assintomático

D) Cintilografia com pirofosfato de tecnécio

---

43 Homem de 58 anos, contador, apresenta febre diária de até 38,6 °C há 5 semanas, com sudorese noturna e perda de 4 kg. Está internado há 8 dias para investigação: três pares de hemoculturas negativos, ecocardiograma transtorácico normal, sorologias para HIV, hepatites B e C, sífilis e toxoplasmose não reagentes, FAN e fator reumatoide negativos, urina tipo 1 e urocultura normais, TC de tórax, abdome e pelve sem alterações. Hemograma sem citopenias, fosfatase alcalina e transaminases normais, VHS 88 mm/h, PCR 9 mg/dL, ferritina 640 ng/mL. Ao exame, não há sopro, linfonodomegalia, hepatoesplenomegalia, lesões de pele, artrite ou alteração de pulsos. Não viajou, não tem animais e não usa medicamentos. O próximo exame mais adequado é:

A) Biópsia de medula óssea

B) PET-CT com FDG

C) Biópsia hepática percutânea

D) Biópsia de artéria temporal

---

44 Homem de 64 anos, com astenia há 4 meses e duas internações por pneumonia no período. Nega etilismo, quimioterapia, radioterapia ou exposição a solventes, e não usa medicamentos. Exame físico com palidez, sem esplenomegalia ou linfonodomegalias. Hemograma: Hb 7,8 g/dL, VCM 109 fL, reticulócitos 0,4%, leucócitos 2.100/mm³ (neutrófilos 700/mm³), plaquetas 34.000/mm³. Vitamina B12, folato, cobre, TSH e função hepática normais; sorologias para HIV e hepatites virais negativas. Biópsia de medula: celularidade de 15%, com micromegacariócitos e megacariócitos hipolobulados em meio ao estroma gorduroso, blastos 3%, sem fibrose. Citometria de fluxo do sangue periférico: clone HPN de 1,5% nos granulócitos. Cariótipo da medula: 45,XY,-7 em 12 de 20 metáfases. O diagnóstico e o achado que o sustenta são, respectivamente:

A) Anemia aplástica / clone HPN

B) Anemia aplástica / monossomia do 7

C) Síndrome mielodisplásica hipocelular / clone HPN

D) Síndrome mielodisplásica hipocelular / monossomia do 7

---

45 Mulher de 44 anos, com asma iniciada aos 38 anos, em uso de budesonida-formoterol em dose alta, rinossinusite crônica e polipose nasal. Há 6 semanas tem febre baixa, perda de 5 kg, parestesias e queda do pé esquerdo; há 5 dias, dispneia aos pequenos esforços e edema de membros inferiores. PA 108/70 mmHg, FC 112 bpm. Eosinófilos 4.800/mm³ (31%), creatinina 0,9 mg/dL, sedimento urinário sem hematúria, ANCA negativo. TC de tórax: opacidades em vidro fosco periféricas. Troponina T ultrassensível 210 ng/L (ref. < 14), BNP 1.400 pg/mL; ecocardiograma com FE de 32% e hipocinesia difusa; coronariografia sem lesões. O tratamento de indução mais adequado é:

A) Pulso de metilprednisolona e ciclofosfamida

B) Prednisona oral isolada

C) Mepolizumabe 300 mg e prednisona

D) Omalizumabe e corticoide inalatório

---

46 Homem de 58 anos tem há 5 meses disfagia para sólidos e líquidos e episódios de dor retroesternal em aperto durante as refeições. Há 8 meses, depois de uma artrodese lombar, toma diariamente um comprimido de liberação prolongada prescrito pelo ortopedista para a dor da coluna, que também lhe trouxe constipação, hoje controlada com macrogol. Cateterismo recente sem lesões coronarianas. Peso estável. Endoscopia normal, com biópsias esofágicas sem eosinófilos; esofagograma sem estenose; TC de tórax e abdome superior normal. Glicemia e TSH normais. Manometria de alta resolução: pressão de relaxamento integrada (IRP) de 19 mmHg (normal até 15 mmHg) e 40% das deglutições com contrações prematuras (latência distal menor que 4,5 s), com peristaltismo normal nas demais. A causa mais provável do quadro é:

A) Efeito do opioide sobre a motilidade esofágica

B) Acalasia tipo III idiopática

C) Pseudoacalasia por neoplasia da cárdia

D) Espasmo esofagiano distal primário

---

47 Homem de 71 anos, com prótese mecânica mitral e fibrilação atrial em uso de varfarina, e com insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 25%, é trazido 90 minutos após o início de hemiparesia esquerda e sonolência. PA 178/96 mmHg, FC 88 bpm irregular, SatO2 95% em ar ambiente, estertores em bases. Glasgow 13. TC de crânio: hematoma capsulonuclear direito de 22 mL, sem extensão ventricular. RNI 2,8; plaquetas 210.000/mm³; creatinina 1,3 mg/dL. Peso 80 kg. O agente para reverter a anticoagulação e o uso de vitamina K são, respectivamente:

A) Complexo protrombínico de 4 fatores / vitamina K 10 mg IV

B) Plasma fresco congelado 15 mL/kg / vitamina K 10 mg IV

C) Complexo protrombínico de 4 fatores / sem vitamina K

D) Plasma fresco congelado 15 mL/kg / sem vitamina K

---

48 Mulher de 29 anos, técnica de enfermagem, com cãibras e fraqueza há quatro meses. Nega vômitos, diarreia, uso de laxantes ou de diuréticos, e conta que vive preocupada com o peso (IMC 19 kg/m²). PA 98/62 mmHg, sem edema, sem erosões dentárias. Exames repetidos em três ocasiões, com resultados semelhantes: potássio 2,7 mEq/L, bicarbonato 32 mEq/L, magnésio 1,3 mg/dL (1,7 a 2,4), creatinina 0,7 mg/dL, cloro urinário em amostra isolada 78 mEq/L, relação cálcio/creatinina urinária 0,03 mg/mg, renina e aldosterona elevadas. Pais não consanguíneos, sem casos semelhantes na família. O exame a solicitar a seguir é:

A) Sequenciamento do gene SLC12A3

B) Pesquisa de diuréticos na urina

C) Relação aldosterona/renina

D) Teste de sobrecarga com tiazídico

---

49 Homem de 41 anos tem psoríase em placas há 15 anos, com 18% da superfície corporal acometida, e artrite psoriásica há 3 anos. Usa metotrexato 20 mg/semana com ácido fólico há 7 meses, com melhora parcial da pele, mas persiste com artrite de duas interfalangeanas distais e dactilite do 3º pododáctilo esquerdo. Há 1 ano surgiu dor lombar e glútea alternante, que o acorda de madrugada e melhora com o movimento; a ressonância de sacroilíacas mostra edema ósseo subcondral bilateral. Sem doença inflamatória intestinal, uveíte, insuficiência cardíaca ou doença desmielinizante; IGRA, HBsAg e anti-HCV negativos. O dermatologista que o acompanha sugere ustequinumabe, com o qual teve ótimos resultados em pele. A escolha mais adequada para o próximo passo é:

A) Apremilaste

B) Ixequizumabe

C) Leflunomida

D) Ustequinumabe

---

50 Homem de 44 anos foi submetido, há 4 meses, a tireoidectomia total com esvaziamento do compartimento central por carcinoma medular esporádico de 2,1 cm (pesquisa germinativa de RET negativa), com 2 de 14 linfonodos centrais comprometidos. Antes da cirurgia, a calcitonina era de 1.240 pg/mL e o CEA de 18 ng/mL. Está assintomático, em uso de levotiroxina 125 µg/dia, com TSH de 1,6 mUI/L e cálcio normal. Exame cervical sem nódulos palpáveis. Exames atuais: calcitonina 86 pg/mL (referência abaixo de 10) e CEA 4,1 ng/mL (referência abaixo de 5). O exame mais adequado neste momento é:

A) Pesquisa de corpo inteiro com iodo-131

B) PET-CT com FDG de corpo inteiro

C) TC de tórax e RM de fígado

D) Ultrassonografia cervical

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 11

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)		